

INDICADO POR: Drº Raphael
☒ ACOMPANHAMENTO ☒ CONSULTA
NS

IVEA MARIA DE MESQUITA - Dirige

IDADE: 83 PESO: 74 ALTURA: 165 PROFISSÃO: Professora - Apos.

SINTOMAS: Ronca (muito) * Já teve depressão
- Pai roncava
- mãe 94a. (após queda) -

QUEIXAS: esquecimento

MEDICAMENTOS: Montileu / Ana 2 / Naxano / Ozempic / Glifage / Crestor / Rivotril
HAS / Dm / Alérgica / Colesterol Trasedona

MÉDICO: Drº Raphael (Neuro) / Drº Celso Guido

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Ritmo (1x semana)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (20h)

HORA QUE DORME: 8h30 HORA QUE ACORDA: 9h

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 12.5 SPO2: 90% média / min. 44%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Bronquite / Fraturou 3 dedos mão E
e ficou em gatilho.

CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: - PRESSÃO NO EXAME: -

08/08 Avaliação p/ CPAP.
25
2021 na pandemia teve um apagão.
2023 - Caiu e bateu a cabeça e ficou esquecido.
2025 Caiu de novo e fraturou a mão (E). Auer

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: IVEA MARIA DE MESQUITA		
Sexo: F	Idade: 79 anos	Peso: 77 Kg
IMC: 28,3	Data do Exame: 04/06/2021	Altura: 1,65 m
		Exame: 21597_01

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:45:53 horas e encerrado às 06:01:25 horas, com latência para o sono de 28 minutos e latência para o sono REM de 208 minutos. O tempo total de sono foi de 354,5 minutos, com eficiência do sono de 81,1%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	2,5%	Até 5%
Estágio 2	83,6%	45 - 55%
Estágio 3	0,0%	> 15%
Sono REM	13,8%	20 - 25%
Eficiência do sono	81,1%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 54 minutos ocorreram **87 despertares (índice de 14,7 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 75 bpm, a maior de 88 bpm e a menor de 65 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 74 eventos respiratórios, sendo 0 central, 74 obstrutivos e 0 misto. Sendo 18 apnéias, 56 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 12,5/hora**, sendo 3,1 apnéia/hora e 9,5 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 18,7 e a duração máxima de 49,1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 19,6/hora, sendo 4,9 apnéia/hora e 14,7 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 94%**, sendo a saturação média de 90%, a maior de 99% e a mínima de 44%, permanecendo 129,8 minutos (29,7%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 5,6 minutos (1,3%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 75 dessaturações. Índice de dessaturações: 12,7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 24,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 11,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.
- 6 - Ausência do sono de ondas lentas.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075